

NMX-22

Registro Nutricional para Enfermedad Renal

Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Registro dietético renal
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Incluye hojas internas ocultas (CALCULOS, VALIDACION_RENAL).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-22_KDOQI_KDIGO(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-22 · Registro Nutricional para Enfermedad Renal
Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Registro dietético renal
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo clínico profesional)
Objetivo	Registrar la ingesta con enfoque renal y evaluar cobertura y reportes, con trazabilidad y matriz renal específicas.
Entradas principales	Alimentación: Registro alimentario; Clínica: Parámetros/metas renales (CONFIG)
Resultados principales	Reporte de cobertura; Matriz renal
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Incluye hojas internas ocultas (CALCULOS, VALIDACION_RENAL).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-22 es un registro nutricional orientado a la enfermedad renal. Sobre la base INTA 2018 evalúa la cobertura de nutrientes con relevancia renal y genera reportes, apoyándose en hojas específicas de trazabilidad y matriz renal. Comparte estructura con NMX-29 (recordatorio 24 h renal) dentro de la Fase 3, con una orientación clínica de apoyo.

NUTRIMETRÍA - NMX-22 - REGISTRO NUTRICIONAL PARA ENFERMEDAD RENAL									
Fase 3 - Evaluación dietética - versión 1.0 - uso propio - 18-07-2026									
DATOS		REGISTRO	ALIMENTOS	CÁLCULOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
Ingresar datos		Ingresar registro	Base de datos INTA	Ver calculos	Cobertura y reportes	Tabla INTA 2018	Casos de prueba	Ajustes y metas	Historial de cambios
Código del producto	NMX-22								
Versión	1.0								
Fecha	2026-07-14								
Método	Recordatorio de 24 horas de pasos múltiples								
Indicador incluido	Adecuación energética y de micronutrientes (FAO/OMS) y calidad del reporte (INTA 2018)								
Formato	.xlsx sin macros - Microsoft 365 y Excel 2021								
Responsable	Equipo Nutrimetría (completar por el titular)								
QUE HACE ESTE LIBRO									
Registra hasta tres días de alimentación de una persona con enfermedad renal y calcula el aporte de energía, proteínas, sodio, potasio, fósforo, calcio y líquidos, comparándolo con metas que dependen de la etapa de la enfermedad y de la situación de diálisis. Muestra además qué alimentos concentran la carga de potasio y fósforo, y advierte cuándo el cálculo está subestimado por falta de datos en la fuente.									
COMO USARLO									
1	En DATOS: registre la situación renal, el peso de cálculo y el laboratorio. Las metas se ajustan solas, pero DEBE revisarlas y editarlas según el caso.								
2	Ingrese manualmente la meta de líquidos: depende de la diuresis residual y del equipo tratante.								
3	En REGISTRO: anote los líquidos por día y luego cada alimento con su día, gramaje y preparación.								
4	En RESULTADOS: revise primero la COBERTURA DEL CÁLCULO; si no es completa, el potasio y el fósforo reales son mayores que los calculados.								
5	Revise los principales aportadores para orientar la educación alimentaria.								
6	En CONFIG: ajuste las metas por situación clínica y los rangos de laboratorio de su institución.								
CÓDIGO DE COLORES									
Arena	Celdas que usted completa								
Gris claro	Celdas calculadas (no escribir)								
Lila	Datos traídos desde otra hoja								
Verde	Potasio, fósforo y aportadores								
Durazno	Advertencias, alertas y límites de uso								
AVISOS - En la fuente INTA el potasio está disponible en el 65,2% de los alimentos y el fósforo en el 69,3%; los totales son valores MÍNIMOS. Las tablas de composición tampoco capturan el fósforo de los aditivos de alimentos procesados, que se absorbe casi por completo. Las metas de potasio y fósforo no son cifras fijas: se ajustan al laboratorio del paciente. Este libro no aplica factores de reducción de potasio por remojo o doble cocción. Los datos provienen de la Tabla INTA 2018 (Universidad de Chile) y se usan de forma personal. Sin validación clínica: es una herramienta de apoyo al registro y al cálculo, no una prescripción dietética ni un diagnóstico, y no reemplaza el juicio profesional ni las indicaciones del equipo de nefrología.									

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Registrar la ingesta con enfoque renal y evaluar cobertura y reportes, con trazabilidad y matriz renal específicas.

Objetivos específicos

- Ingresar el registro alimentario con enfoque renal.
- Revisar cobertura y reportes de nutrientes críticos.
- Consultar la trazabilidad y la matriz renal.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo clínico profesional)

Población de referencia (según el libro)

Enfoque renal; base INTA 2018 con cobertura crítica para uso renal.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Registro renal	Captura la ingesta con enfoque renal	Alimentos y cantidades	Registro renal	Intermedio
Cobertura y reportes	Evalúa nutrientes críticos renales	Registro	Reporte de cobertura	Intermedio
Matriz renal	Clasifica alimentos según relevancia renal	Base INTA	Matriz renal	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Alimentación

Registro alimentario

Clínica

Parámetros/metas renales (CONFIG)

REGISTRO NUTRICIONAL - HASTA 3 DÍAS

Registre todo lo consumido. En diálisis se recomienda incluir un día de diálisis y uno sin diálisis.

REGIDOR

REGISTRO

ALIMENTOS

CALCULOS

RESULTADOS

FUENTES

PRUEBAS

CONFIG

CHANGELOG

LÍQUIDOS INGERIDOS POR DÍA (bebidas, aguas, sopas, hielo)

Día	Líquidos ingeridos (mL)	¿Fue día de diálisis?	Observaciones
1	600	SI	
2			
3			

El agua contenida en los alimentos se calcula aparte y se suma a estos líquidos para estimar el aporte total.

REGISTRO DE ALIMENTOS (60 líneas)

Nº	Día	Hora	Tiempo de comida	Alimento (base INTA)	Preparación declarada	Gramos	Forma de estimación	Observaciones	Control de coherencia
1	1	08:00	Desayuno	Pan blanco sin sal	Crudo o sin cocción	80	Pesado	Dos rebanadas	
2	1	08:00	Desayuno	Leche fluida entera	Crudo o sin cocción	100	Medida casera	Medida taza	
3	1	08:00	Desayuno	Azúcar	Crudo o sin cocción	10	Medida casera	Dos cucharaditas	
4	1	11:00	Colación AM	Manzana	Crudo o sin cocción	120	Pesado	Una unidad chica	
5	1	13:30	Almuerzo	Arroz blanco cocido	Cocido	150	Pesado	Una taza	OK
6	1	13:30	Almuerzo	Pollo pechuga	Asado o al horno	120	Pesado	Una presa	REVISAR: preparación cocida con alimento crudo
7	1	13:30	Almuerzo	Zanahoria	Crudo o sin cocción	80	Pesado	Ensalada	
8	1	13:30	Almuerzo	Aceite de oliva	Crudo o sin cocción	10	Medida casera	Una cucharada	
9	1	17:00	Once	Pan hallulla	Crudo o sin cocción	50	Pesado	Medida unidad	
10	1	20:30	Cena	Papa cocida	Cocido	150	Pesado	Una unidad mediana	OK
11	1	20:30	Cena	Huevo entero	Cocido	55	Pesado	Una unidad	REVISAR: preparación cocida con alimento crudo
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

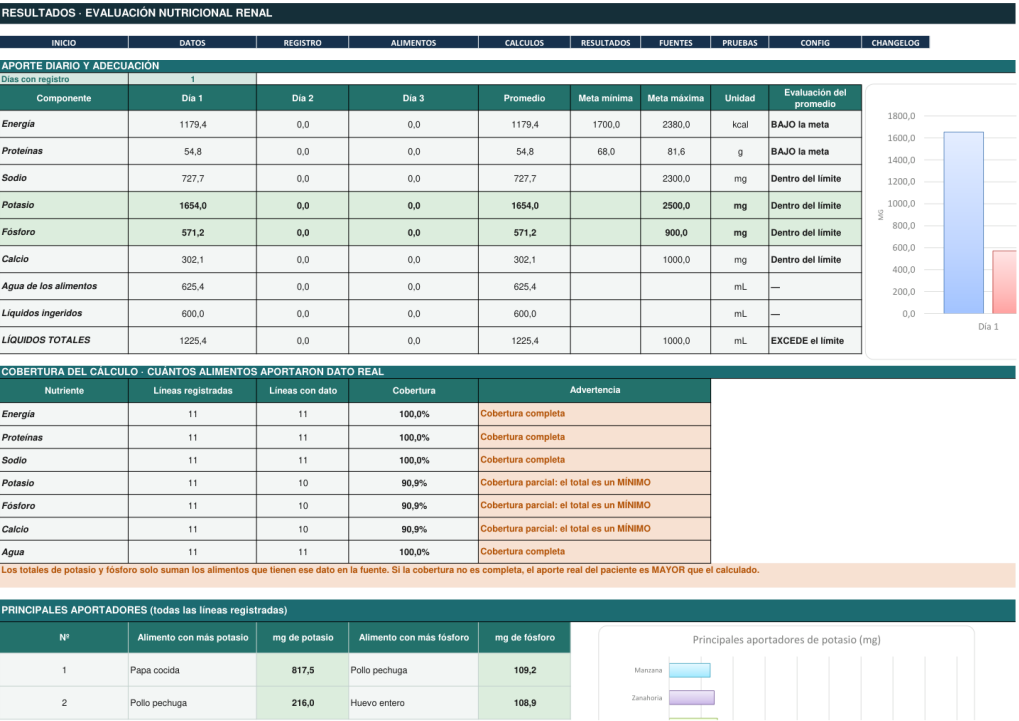
07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Reporte de cobertura	INFORME	por nutriente	Depende del registro
Matriz renal	REGISTRO	clasificación	Depende de la base

NUTRIMETRÍA

NMX-22 · Registro Nutricional para Enfermedad Renal

Pág. 4



FUENTES Y TRAZABILIDAD												
INICIO	DATOS				REGISTRO	ALIMENTOS	CÁLCULOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS												
Elemento					Detalle							
Otra												
Tabla de Composición de Alimentos												
Institución												
NTA, Universidad de Chile												
Edición año												
2019												
Base de cálculo												
Por 100 g de porción comestible												
Alimentos incorporados												
616												
COBERTURA CRÍTICA PARA USO RENAL												
Potasio: 403 de 616 alimentos (65,2%). Fósforo: 438 (88,3%). Calcio: 443 (71,7%). Sodio: 567 (91,7%). Los grupos peer cubiertos son precisamente los de mayor relevancia renal: platos preparados y productos salados no tienen ningún dato de potasio; en lácteos el potasio está en el 52,8% de los registros y en carnes y vísceras en el 64,2%. Todo total de potasio o fósforo obtenido con esta base debe leerse como un valor MÍNIMO.												
FÓSFORO DE ADITIVOS												
Las tablas de composición reflejan el fósforo natural del alimento y no el añadido como aditivo en productos procesados. El fósforo inorgánico de los aditivos tiene absorción muy alta, por lo que la carga real puede ser considerablemente mayor que la calculada. Revise siempre el etiquetado.												
CORRECCION APLICADA - grupo 2.10												
El archivo fuente no incluye la fila de cobertura del grupo 2.10 (verduras y hortalizas): 31 alimentos quedaban amarrando 'sietes y grasas'. Se reconstruyó el grupo y cada registro corregido queda marcado. Los valores nutricionales NO fueron alterados.												
Data fuente												
"v" = sin información --> se muestra como "N/A", nunca como 0												
Uso de este archivo												
Uso personal del titular. No redistribuir ni comercializar la base sin autorización de NTA / U. de Chile												
Respeto institucional												
Este libro NO cuenta con respaldo ni aval de NTA ni de la Universidad de Chile												
REFERENCIAS NUTRICIONALES EN ENFERMEDAD RENAL												
Elemento					Referencia y alcance							
Proteínas y energía					KDIGO Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD, actualización 2020 (Kotler y cols., American Journal of Kidney Diseases), EPO 3-5 en diabéticos y metabolismo estable, sin diabetes: 0,55-0,60 g/kg/día, con diabetes: 0,60-0,80 g/kg/día. Hemodiálisis y diálisis peritoneal: 1,00-1,20 g/kg/día. Energía: 25-35 kcal/kg/día ajustada por edad, sexo, actividad y composición corporal.							
Sodio					Límite inferior a 2000 mg/día (100 mmol) en EPO 3-5, diabético y trasplante, para control de presión arterial y volumen - KDIGO 2020.							
Potasio y fósforo					KDIGO 2020 no fija una cifra única de potasio o fósforo: ajustar la ingesta para mantener valores séricos en rango, considerando biodisponibilidad, aditivos, tratamiento y contexto. CONFINO ya no prescarga límites universales; las metas se documentan manualmente en DATOS.							
Calcio					800-1000 mg/día en EPO 3-4 que no reciben análogos activos de vitamina D - KDIGO 2020.							
Líquidos					No se deriva de nada alguna, depende de la diuresis residual y del criterio del equipo tratante. Se ingresa manualmente.							
Peso de cálculo					La guía establece peso actual, ajustado o libre de edema según el caso; en diálisis, suele usarse el peso seco post-diálisis. La elección se registra explícitamente en la hoja DATOS.							
Razón fósforo/proteína					Indicador descriptivo que expresa los miligramos de fósforo por gramo de proteína del alimento, útil para priorizar fuentes proteicas de menor carga fósforica. Es una herramienta de comparación, no un objetivo terapéutico normado.							
Rango de laboratorio					Los rangos prescargados son orientativos y estables. Varían entre laboratorio y, en diálisis, los objetivos de PTH y bicarbonato dependen del criterio del equipo de nefrología.							
KDIGO 2024 - evaluación y manejo					Clasificación CGA, confirmación de toxicidad, uso conjunto de TPO y ACR y criterios de derivación. Implementado en TRAZABILIDAD, RENAL y VALIDACIÓN, RENAL.							
KDIGO 2024 - fuente oficial					https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/							
KDIGO 2024 - PDF					https://kdigo.org/wp-content/uploads/2024/05/KDIGO-2024-CKD-Guideline.pdf							
KDIGO 2020 - fuente oficial					https://www.kidney.org/professionals/kdigo/guidelines-and-commentaries/nutrition-ckd							
KDIGO 2020 - DOI					https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.05.005							
KDIGO 2020					Actualización finalizada y enviada en marzo de 2020. Estado: EN DESARROLLO, NO IMPLEMENTAR.							
KDIGO 2020 - anuncio oficial					https://kdigo.org/kdigo-announces-update-to-2024-ckd-guideline/							

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 13 hojas (8 visibles y 5 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 331 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 13 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Registro ficticio de ingesta en contexto renal.
Proceso	Se ingresa el registro alimentario.
Resultado	El libro evalúa cobertura de nutrientes críticos y arma el reporte.
Interpretación educativa	El profesional interpreta la cobertura según la situación clínica.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

DATOS - SITUACIÓN CLÍNICA, LABORATORIO Y METAS

Complete solo las celdas de color arena. Las grises se calculan solas.

INICIO

DATOS

REGISTRO

ALIMENTOS

CÁLCULOS

RESULTADOS

FUENTES

PRUEBAS

CONFIG

CHANGELOG

IDENTIFICACIÓN

Nombre o identificador

Caso de ejemplo

Edad (años)

62

Sexo

Masculino

Talla (m)

1,68

Fecha del registro

2026-07-17

Profesional responsable

—

SITUACIÓN RENAL Y PESO DE CÁLCULO

Situación clínica

Hemodialis de mantención

Tasa de filtración glomerular estimada (TFGe)

—

ml/min/1.73 m²

Peso actual (kg)

68

Base de peso usada para las metas

Peso actual

Peso de cálculo (kg)

68

Índice de masa corporal

24.1

kg/m²

En diálisis se recomienda usar el peso seco post-diálisis; en obesidad puede corresponder peso ajustado. La elección de la base de peso es una decisión clínica: escribala explícitamente en 'Peso de cálculo'.

LABORATORIO

Parámetro

Valor

Unidad

ango de referenc

Interpretación

Potasio sérico

5,9

mEq/L

3,5 – 5,5

SOBRE el rango

Fósforo sérico

5,2

mg/dL

2,5 – 4,5

SOBRE el rango

Calcio sérico

8,8

mg/dL

8,5 – 10,5

Dentro del rango

Albumina sérica

3,6

g/dL

4 – 5,5

BAJO el rango

PTH intacta

720

pg/mL

150 – 600

SOBRE el rango

METAS NUTRICIONALES APLICADAS AL CASO

Componente

Meta mínima

Meta máxima

Unidad

Base de la meta

Energía

1700,0

2380,0

kcal/día

kcal/kg × peso de cálculo - KDOQI 2020

Proteínas

68,0

81,6

g/día

g/kg × peso de cálculo - KDOQI 2020

Sodio

2300,0

mg/día

<2300 mg/día si corresponde - KDOQI 2020

Potasio

2500,0

mg/día

Meta clínica ingresada - ajustar según kalemia

Figura 5. Pantalla de ingreso de datos.

NUTRIMETRÍA

NMX-22 · Registro Nutricional para Enfermedad Renal

Pág. 7

37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

Figura 6. Pantalla de ingreso de datos.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
CRITERIO	Registro con enfoque renal y cobertura crítica	Renal	Reportes	Requiere interpretación profesional

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	Base alimentaria	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Enfoque renal de apoyo; la interpretación clínica corresponde al profesional. La cobertura depende de la base INTA. No sustituye guías clínicas ni el juicio del equipo tratante.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo clínico profesional
- No reemplaza el juicio profesional
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-29 • Recordatorio de 24 Horas Renal
- NMX-42 • Explorador Renal de Alimentos y Equivalentes
- NMX-13 • Recordatorio de 24 Horas (con catálogo PAL, NMX-01)

Versionado

Producto_ID	NMX-22
Archivo analizado	NMX-22_KDOQI_KDIGO(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-22 · Registro Nutricional para Enfermedad Renal

Fase 3 · Evaluación y Registro · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.